

INF03 Übung 1 – semantische Interoperabilität – ja, aber wie?

Thema und Ziel

In der Übung werden Sie sich mit dem Begriff der semantischen Interoperabilität an einem Beispiel aus der Praxis auseinandersetzen. Sie werden für einen Anwendungsfall Strategien entwerfen, um eine semantisch interoperable Kommunikation im Gesundheitswesen aufzubauen.

Bilden Sie dafür bitte vier Kleingruppen, idealerweise so, dass in jeder Gruppe jemand bereits Kontakt zu Standards wie HL7 V2, HL7 CDA, HL7 FHIR und wichtigen Terminologien hatte.

Folgende Links könnten interessant sein:

- Österreichische CDA Implementierungsleitfäden im Wiki: <https://wiki.hl7.at/index.php?title=Implementierungsleitf%C3%A4den>
- HL7 FHIR Resource List: <https://www.hl7.org/fhir/resourcelist.html>
- Aufbereitung von HL7 V2 Nachrichten und Trigger Events <https://hl7-definition.caristix.com/v2/HL7v2.5.1/TriggerEvents>

Aufgabenstellung

1. Wählen Sie eine konkrete Transaktion im eHealth-Umfeld, mit der sie sich für die Dauer der Übung intensiver beschäftigen wollen (Beispiele siehe Seite 2)
2. Überlegen Sie sich, welche Daten Sie in Ihrem Szenario austauschen wollen. Legen Sie fest, in welcher Form diese Daten vorliegen sollen (wie strukturiert, maschinenlesbar?). Vielleicht haben Sie schon einen Vorschlag für passende Terminologien.
3. Werfen Sie einen Blick in die entsprechende Original-Spezifikation (FHIR-Ressource im Überblick, HL7 V2 Segment, CDA-Leitfaden und Beispieldokument im Wiki) und gleichen Sie die Vorgaben mit Ihrer Liste aus Punkt 2 ab.
4. Diskutieren Sie in der Gruppe folgende Fragen (gerne auch weitere), und fassen Sie Ihre Ergebnisse kurz und bündig zusammen:
 - a) Was bedeutet semantische Interoperabilität im ganz konkreten Fall, wie hebt sie sich von technischer Interoperabilität ab?
 - b) Was muss geleistet werden, damit Ihre Transaktion semantisch interoperabel ablaufen kann? Wer muss was leisten (z.B. Standardisierer, Gesetzgeber, Standesvertreter, schreibende und lesende Akteure, Software-Hersteller)
 - c) Welchen Nutzen hat semantische Interoperabilität in Ihrem konkreten Fall für wen? Welchen Nutzen bietet bereits die technische Interoperabilität?
 - d) Welche Stolpersteine könnte es bei der Umsetzung Ihrer Idee geben?
 - e) Was würde dafür sprechen, hier auf keinen (nationalen/internationalen) Standard zu setzen? Wie könnte eine Lösung ohne Standard aussehen? Was wäre dadurch leichter? Was würde verloren gehen?

Beispiele Anwendungsfälle:

1. Die Steiermark erhält ein neues medizinisches Zentrallabor, das Aufträge aus allen LKH entgegen nimmt und die Laborergebnisse ans KIS sendet. Die Abwicklung erfolgt mittels HL7 V2 Nachrichten (ORM und ORU – Sie können sich für Punkt 3 gern auf das OBX-Segment beschränken)
2. Ein Disease Management Programm zur Betreuung von Herzinsuffizienz-Patienten will den ELGA-CDA-Telemonitoring Episodenbericht nutzen. Die Daten aus den verwendeten Geräten wie Blutdruck-Messgeräten und Waagen werden mittels Smartphones ausgelesen und in das Dokument geschrieben.
3. Eine Projektgruppe will einen HL7 FHIR basierten Allergiepass entwickeln, im ersten Schritt sollen bestehende Allergien von Patienten erfasst werden.
4. Eigene Beispiele sind sehr willkommen!